

SOAL UJIAN OSCE
STATION : ICU

1.	Nomor Station	8B
2.	Judul Station	Cushing Reflek – Ventilator dan Tatalaksana Peningkatan TIK
3.	Alokasi Waktu	17 menit
4.	Tujuan Station	Menilai kemampuan mengenali peningkatan tekanan intra kranial lanjutan, dan kemampuan penatalaksanaan pengendalian peningkatan tekanan intrakranial di unit rawatan intensif, Komunikasi, Edukasi dan Profesionalisme
5.	Kompetensi Diujikan	1. <i>Initial Assessment / Primary Survey</i> 2. Kemampuan Tes / Prosedur Klinis atau Interpretasi Data untuk Menunjang Diagnosis 3. Kemampuan Memprediksi Penyulit dan Diagnosis Definitif Pasien Kritis 4. Kemampuan Penatalaksanaan Pasien Kritis dan Penyulit (Farmakologis dan Non-Farmakologis) 5. Kemampuan Monitoring 6. Komunikasi, Edukasi dan Profesionalisme
6.	Kategori	1. Anestesia Obstetrik 2. Anestesia Bedah Saraf 3. Anestesia Regional Dan Manajemen Nyeri 4. Anestesia Bedah Toraks 5. Anestesia Pediatrik 6. Anestesia Kegawatdaruratan 7. Anestesia Urologi 8. Anestesia Untuk Penyakit Penyakit Khusus (Endokrin, Metabolik, Penyulit Kardiovaskular) 9. Anestesia Bedah Kepala Leher 10. Anestesia Bedah Rawat Jalan / Luar Kamar Bedah 11. Anestesia Pada Prosedur Invasif Minimal 12. Terapi Intensif

7. Instruksi Peserta Ujian	<u>Skenario Klinik:</u> Seorang laki laki berusia 45 tahun, panjang badan 163 cm dirawat di ICU setelah menjalani operasi craniotomi <i>evakuasi SDH</i> dua hari yang lalu, dengan GCS E4M5VEtt direncanakan untuk ekstubasi, namun tiba tiba pasien mengalami kejang <u>Instruksi Peserta :</u> 1. Lakukan initial assesment pada kasus tersebut 2. Usulkan pada penguji pemeriksaan penunjang dan interpretasinya! 3. Sampaikan pada penguji tata laksana sesuai diagnosis tersebut 4. Lakukan tatalaksana setting ventilator, jika saat ini didapatkan EtCO2 50
-----------------------------------	---

8.	Instruksi Penguji	<u>INSTRUKSI UMUM</u> 1. Pastikan identitas peserta ujian pada kartu ujian 2. Tulislah nama dan nomor peserta ujian pada lembar penilaian! 3. Amatilah dan berilah skor (0/1/2/3) atas tugas yang dikerjakan peserta ujian serta skor <i>Global Rating</i> sesuai rubrik penilaian. 4. Hindarilah interupsi dan/atau tindakan selain daripada yang diminta dalam instruksi penguji! 5. Berikan informasi/ hasil yang dibutuhkan secara lisan/ tulisan hanya apabila peserta ujian telah melakukan dan/ atau mengusulkan jenis pemeriksaan yang dimaksud (perhatikan instruksi khusus)! 6. Taatilah peraturan serta etika penguji selama menjalankan tugas sebagai penguji OSCE - ATI! <u>INSTRUKSI KHUSUS</u> 1. Penguji menilai kemampuan peserta untuk melakukan initial assesment . Penguji menyampaikan hasil setelah kandidat melakukan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan : Airway : Bebas terintubasi Breathing : Ventilator : Pressure control : PC 12 frekuensi 15 PEEP 5 FiO2 30% didapatkan tidal volume ekspirasi 300 ml frekuensi 10 x/menit minute volume ekspirasi 3,0 l ,SpO2 98% etCO2 50, rektrasi iga (-), , pernafasan cuping hidung (-) . suara nafas vesikuler (+/+)
----	-------------------	--

Setting ventilator sesuai dengan yang tampak di ventilator :

Circulation :

Tekanan darah 190/110 mmHg, Laju nadi 48 kali/menit teraba halus, akral dingin. Temperatur 36.5C

Disability :

Pasien berespon dengan rangsangan nyeri, pupil anisokor (6/3) RC (+ lambat/+)

2. Penguji memberikan hasil pemeriksaan penunjang setelah diajukan peserta

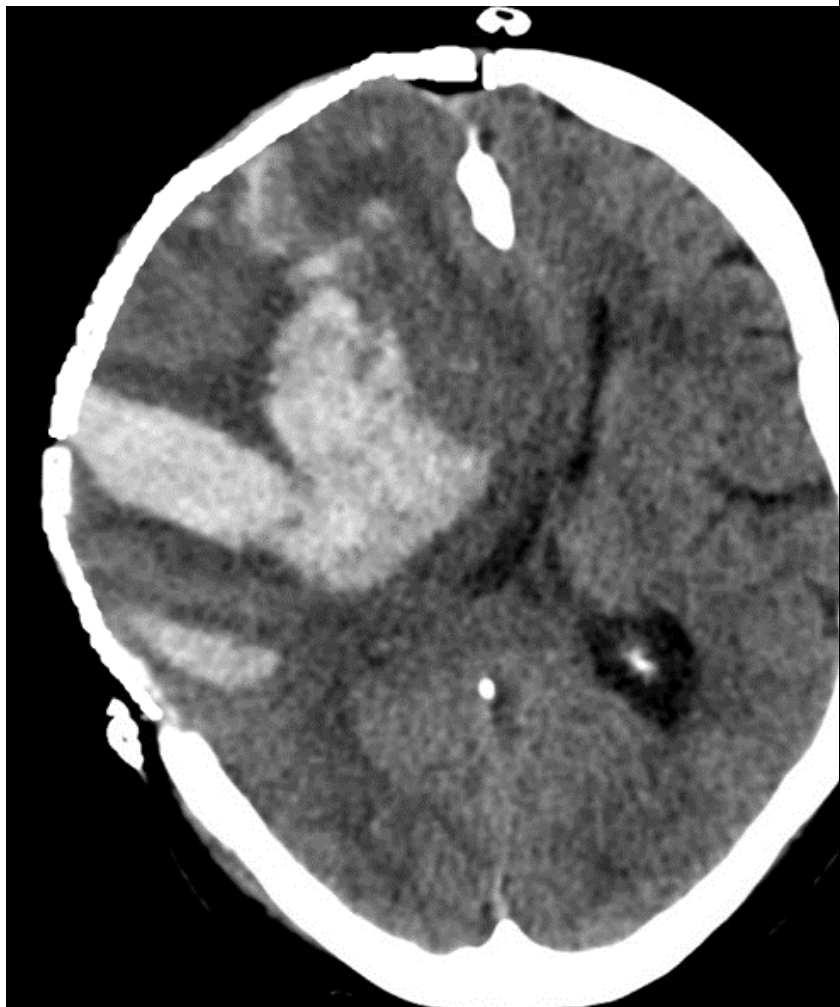
AGD : pH : 7.199 pCO₂ : 53.1 pO₂ : 150 HCO₃ : 20.7 BE : -7 SaO₂ 98%

Interpretasi : Acidosis respiratorik dan metabolik,

Hb 7,4 Ht 25 Leukosit 10.000 Trombosit 230.000

Interpretasi : Anemia

CT scan :



Intepretasi :

Midline shift : Edema cerebri, didapatkan midline shift, ventrikel menyempit

3. Peserta ujian menyebutkan tata laksana sesuai diagnosis :

- a. Posisi head up 30 derajat
- b. Kontrol ventilasi : Hiperventilasi target PCO₂ 30-35.
- c. Terapi hiperosmoler , mannitol 0,25 – 1 gr/kgBB
- d. Ventrikulostomi
- e. Kraniektomi
- f. Koma barbiturate
- g. Mild Hypotermi
- h. Tranfusi PRC target Hb >10

4. Penguji menilai *setting* ventilasi mekanik peserta ujian

1. Menentukan mode ventilator: Pressure Control atau Volume Control
2. Menentukan Predicted Body Weight (PBW)
 $PBW = 50 + 0,91 \times (160 - 152,4) = 59,6 \approx 60 \text{ kg}$
3. Menentukan Volume Tidal (VT) = 6-8 ml/kg
 $VT = 360 - 480 \text{ ml}$
(Jika, Pressure control maka P inspirasi disetting sampai target VT tersebut)
4. Menentukan Minute Ventilation (MV)
 $MV = 100 \text{ ml/kg} = 5 \text{ L}$
5. Menentukan laju napas (RR)
 $RR = MV/VT = 11 - 14 \text{ x/menit}$
6. Menentukan PEEP
PEEP awal = 5 cmH₂O
7. Menentukan FiO₂
FiO₂ awal 100%, kemudian diturunkan sampai SpO₂ $\geq 95\%$
8. Menentukan I:E ratio
I:E ratio awal = 1:2
9. Mengamati Pplateau di monitor
Pplateau tidak lebih dari 30 cmH₂O
10. Memeriksa AGD pasca *setting* awal

9.	Tata letak station	Setting ruang ICU
10	Kebutuhan Laboran	Jumlah Laboran : 1 orang Tugas laboran : sebagai perawat unit rawat intensif
11	Peralatan Yang Dibutuhkan	Setting Ruang ICU Setting peralatan ICU Manekin Alat dan obat intubasi Ventilator Flashlight Foto CT-scan Kalkulator
12	Kebutuhan Manekin	Manekin airway trainer, sudah terintubasi dan terhubung dengan ventilator

13	Penulis	Tim soal OSCE
14	Referensi	Morgan & Mikhail's Clinical Anesthesiology. Ch 26. Neurophysiology. 2022 Morgan & Mikhail's Clinical Anesthesiology. Ch 27. Anesthesia for neurosurgery. 2022 Brain trauma foundation guidelines, 2018.

**RUBRIK PENILAIAN OSCE
STATION : XX**

I. Rubrik

KOMPETENSI	0	1	2	3	BO BO T	SK OR
1. <i>Initial Assessment / Primary Survey</i>	Kandidat tidak melakukan initial assessment	Kandidat mampu melakukan semua pemeriksaan fisik sesuai masalah klinik pasien dengan menerapkan prinsip sebagai berikut namun tidak lengkap: Pemeriksaan tanda vital 1. Airway 2. Breathing 3. Circulation 4. Disability	Tidak ada nilai 2	Kandidat mampu melakukan semua pemeriksaan fisik sesuai masalah klinik pasien dengan menerapkan prinsip sebagai berikut: Pemeriksaan tanda vital a. Airway b. Breathing c. Circulation d. Disability	2	
2. Kemampuan Tes / Prosedur Klinis atau Interpretasi Data untuk Menunjang Diagnosis	Peserta ujian tidak dapat mengusulkan pemeriksaan penunjang dengan tepat	Peserta ujian hanya mengusulkan satu pemeriksaan penunjang dan memberikan interpretasinya dengan tepat	Peserta ujian hanya mengusulkan dua pemeriksaan penunjang dan memberikan interpretasinya dengan tepat	Peserta ujian mengusulkan pemeriksaan penunjang dan memberikan interpretasinya dengan tepat meliputi pemeriksaan: 1. DL 2. AGD 3. CT - scan	2	
4. Kemampuan Penatalaks	Peserta ujian tidak menyebutkan tata	Peserta ujian menyebutkan tata laksana	Peserta ujian menyebutkan tata laksana sesuai dengan diagnosis minimal 5 - 7 poin	Peserta ujian menyebutkan tata laksana sesuai dengan diagnosis.	2	

anaan Pasien Kritis dan Penyulit (Farmakolo gis dan Non- Farmakolog is))	laksana sesuai dengan diagnosi.	sesuai dengan diagnosis minimal 2 - 4 poin		1. Posisi head up 30 derajat 2. Kontrol ventilasi : Hiperventilasi target PCO2 30-35. 3. Terapi hiperosmoler , mannitol 0,25 – 1 gr/kgBB 4. Ventrikulostomi 5. Kraniektomi 6. Koma barbiturate 7. Mild Hypotermi 8. Tranfusi PRC target Hb >10		
5.	Mampu melakukan <3 penatalaksanaan pasien kritis dengan lengkap	Mampu melakukan 3-6 penatalaksanaan pasien kritis dengan lengkap	Mampu melakukan 7-9 penatalaksanaan pasien kritis dengan lengkap	Mampu melakukan penatalaksanaan pasien kritis dengan LENGKAP 1. Menentukan mode ventilator: Pressure Control atau Volume Control 2. Menentukan Predicted Body Weight (PBW) 3. Menentukan Volume Tidal (VT) = 6-8 ml/kg 4. Menentukan Minute Ventilation (MV) 5. Menentukan laju napas (RR) 6. Menentukan PEEP 7. Menentukan FiO₂ 8. Menentukan I:E ratio 9. Mengamati Pplateau di monitor 10. Memeriksa AGD pasca <i>setting</i> ventilator	3	

6. Komunikasi, Edukasi dan Profesionalisme	Peserta ujian tidak meminta izin secara lisan dan sama sekali tidak melakukan poin berikut: 1. melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. memperhatikan kenyamanan pasien 3. melakukan tindakan sesuai prioritas 4. menunjukkan rasa hormat kepada pasien 5. mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan	Meminta izin secara lisan dan 1-2 poin berikut : 1. melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. memperhatikan kenyamanan pasien 3. melakukan tindakan sesuai prioritas 4. menunjukkan rasa hormat kepada pasien 5. mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan	Meminta izin secara lisan dan 3 poin berikut: 1. melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. memperhatikan kenyamanan pasien 3. melakukan tindakan sesuai prioritas 4. menunjukkan rasa hormat kepada pasien 5. mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan	Meminta izin secara lisan dan melakukan di bawah ini secara lengkap: 1. melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. memperhatikan kenyamanan pasien 3. melakukan tindakan sesuai prioritas 4. menunjukkan rasa hormat kepada pasien 5. mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan	1	
--	--	---	--	---	---	--

